

PROPOSAL
PENGARUH PEMBERIAN TERAPI RELAKSASI AUTOGENIK
TERHADAP TINGKAT NYERI PRE OPERASI PADA PASIEN
PRO EXCISI TUMOR MAMAE DI RUANG IKO
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO



Oleh :

FARID WAHYUDI ANTOK

NIM :2024030262

PROGAM STUDI ILMU KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN HUSADA JOMBANG

2025

PROPOSAL
PENGARUH PEMBERIAN TERAPI RELAKSASI AUTOGENIK
TERHADAP TINGKAT NYERI PRE OPERASI PADA PASIEN
PRO EXCISI TUMOR MAMAE DI RUANG IKO
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO



Oleh :

FARID WAHYUDI ANTOK

NIM :2024030262

PROGAM STUDI ILMU KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN HUSADA JOMBANG

2025

SURAT PERNYATAAN

Saya Bersumpah Bahwa Proposal Ini Adalah Hasil Karya Sendiri Dan Belum Pernah Dikumpulkan Oleh Orang Lain Untuk Memperoleh Gelar Dari Berbagai Jenjang Di Perguruan Tinggi Manapun. Saya siap menyerahkan Softcopy untuk keperluan institusi baik kepengarangan atau publikasi

Jombang,.....2025

Yang Menyatakan

Farid Wahyudi Antok
NIM: 2024030262

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal ini telah di konsulkan dan siap dipresentasikan dan dipertanggung jawabkan pada sidang Proposal pada.

Hari :.....

Tanggal :.....

Oleh
Pembimbing I

Karisma Dwi Ana, S Kep., Ns., M.Kep
NPP: 011 305 108

Pembimbing II

Fahrur Rozi, S.Kep., Ns., M.Kep
NPP: 010906068

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Proposal telah diuji dan di tetapkan

Pada Tanggal :

PANITIA PENGUJI

Ketua : **Yusina Vidhiastutik, S.Kep., Ns.** : (.....)
NPP: 010905055

Anggota I : **Karisma Dwi Ana, S.Kep., Ns., M.Kep** : (.....)
NPP: 011305108

Anggota II : **Fahrur Rozi, S.Kep., Ns., M.Kep** : (.....)
NPP: 010906068

Mengetahui
Ketua STIKES Husada
Jombang

Ka. Prodi S1 Keperawatan STIKES
Husada Jombang

Dra. Hj. Soelijah Hadi, M.Kes., MM
NPP : 010201001

Sylvie Puspita, S. Kep., Ns., M.Kep
NPP : 011305103

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penelitian mampu menyelesaikan Proposal yang berjudul “Pengaruh Pemberian Terapi Relaksasi Autogenik Terhadap Tingkat Nyeri Pre Operasi pada Pasien Excisi Tumor Mamae Di Ruang IKO di RS Prima Husada Sukorejo”. Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Proposal ini masih banyak kekurangan namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin sehingga dapat menyelesaikan, baik melalui konsultasi dengan pembimbing dan membaca berbagai jurnal/literatur. Oleh karena itu ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep, selaku direktur rumah sakit Prima Husada Sukorejo atas arahan dan penjelasan saat pengambilan data saya ucapkan terimakasih.
2. Dra. Hj. Soelijah Hadi, M.Kes., MM, selaku Ketua STIKES Husada Jombang, yang telah memberikan kenyamanan pada mahasiswa.
3. Sylvie Puspita, S. Kep., Ns., M.Kep selaku Kaprodi S1 Keperawatan STIKES Husada Jombang, yang telah memberi arahan kepada saya.
4. Yusina Vidhiastutik, S.Kep., Ns, selaku dosen penguji atas arahan dan masukan saya mengucakan banyak terimakasih.
5. Karisma Dwi Ana, S.Kep., Ns., M.Kep, selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, dan saran yang diberikan kepada saya sehingga proposal saya ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Fahrur Rozi, S.Kep., Ns., M.Kep, selaku pembimbing 2 saya yang telah memberikan ilmu kepada saya dan sabar membimbing saya.

7. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa STIKes Husada Jombang, selalu memberikan dukungan kepada saya dan motivasi saat penyelesain proposal ini
8. Keluargaku tercinta yang selalu memancurahkan cinta kasih sayangnya dan do'a-do'a dalam setiap langkahku.

Peneliti menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat masih terbatasnya ilmu dan pengalaman, oleh karena itu peneliti tidak menutup diri bila ada kritik dan saran yang bersifat membangun agar penyusunan proposal ini lebih sempurna di mas yang akan datang. Semoga penyusun proposal ini dapat bermanfaat dan berguna bagi profesi dan para pembacanya.

Jombang,.....2025

Farid Wahyudi Antok
NIM: 2024030262

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tumor mammae adalah adanya pertumbuhan massa atau benjolan yang terjadi pada jaringan payudara (Aisy dkk., 2024). Salah satu tanda dan gejala penyakit tumor mammae sebelum dilakukan pre-operasi adalah nyeri. Nyeri adalah suatu bentuk ketidaknyamanan secara individual (Nurhanifah & Sari, 2022). Nyeri yang dialami oleh pasien penyakit tumor mammae dapat dikurangi dengan pemberian terapi relaksasi autogenik. Terapi relaksasi autogenik adalah terapi relaksasi yang bersumber dari diri sendiri berupa kata/kalimat pendek ataupun pikiran yang bisa membuat pikiran tenang (Atmojo, 2023).

Sesuai data World Health Organization (WHO) tahun 2020 saat ini, 2,3 juta wanita di seluruh dunia telah terdiagnosis kanker payudara, jumlah total kematian di seluruh dunia adalah 685.000. Kanker payudara adalah kanker yang paling umum di kalangan wanita di 173 dari 183 negara 95% (Renita dkk., 2023). Data yang didapat dari dinas kesehatan Indonesia bahwa tumor payudara merupakan penyakit yang berkontribusi angka kematian tertinggi pada perempuan sekitar 3.404 kasus kanker payudara dan 18.150 kasus tumor payudara (Hafsah, 2022). Data prevalensi Provinsi Jawa Timur yang telah menjalani deteksi dini kanker payudara terdeteksi adanya benjolan sebanyak 6.638 orang dan data penyakit tumor payudara di Kabupaten Pasuruan sebanyak 5,9% (Dinkes Jatim, 2024). Data pasien kanker payudara di rumah sakit Prima Husada sebanyak 30 orang pada bulan September 2025 (Rekam Medis RSPH, 2025).

Tumor payudara adalah suatu penyakit tumor yang ganas yang berkembang di dalam jaringan payudara. Tumor payudara belum ada penyebab yang pasti (Nor, 2024). Terdapat benjolan di sekitar payudara atau ketiak, keluarnya cairan diputing, dan ada rasa nyeri disekitar payudara (Cahyawati & Wedayani, 2024). Tumor payudara memiliki empat stadium, stadium paling berbahaya adalah stadium empat. Pada stadium empat ini tumor sudah menyebar ke seluruh tubuh (Supriyanto dkk., 2022).

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan pada pasien tumor payudara adalah operasi. Nyeri yang dialami pasien tumor payudara adalah rasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari (Bachtiar, 2022). Penurunan nyeri sebelum operasi dapat dilakukan pemberian terapi non-farmakologi yaitu terapi relaksasi autogenik. Terapi relaksasi autogenik adalah terapi teknik relaksasi diri melalui pengulangan kalimat afirmatif positif yang memengaruhi sistem saraf otonom untuk mencapai kondisi tenang dan rileksi (Atmojo, 2023). Terapi relaksasi autogenik memiliki manfaat untuk menurunkan tingkat nyeri (Subiyakto & Ariyani, 2024). Selain itu, terapi relaksasi autogenik memiliki manfaat antara lain menurunkan tekanan darah, menurunkan kecemasan, dan mengurangi kelemahan (Atmojo, 2023).

Prosedur pelaksanaan terapi autogenik adalah memberikan kalimat positif kepada pasien yang mengalami nyeri atau berupa narasi positif agar nyeri yang dialami oleh pasien menurun (Hati dkk., 2023). Terapi relaksasi autogenik tidak dianjurkan anak dibawah 5 tahun dan individu yang memiliki masalah berat (Atmojo, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Zhang (2022) bahwa menemukan ART mengurangi nyeri subjektif preoperatif sebesar 28% ($p < 0.05$) melalui latihan relaksasi otomatis. Studi kontrol acak dengan follow-up pascaoperasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh K. Tanaka (2024) bahwa menunjukkan ART efektif menurunkan nyeri preoperatif dengan efek ukuran sedang ($SMD = -0.48$). Rekomendasi untuk integrasi dalam perawatan preoperatif, terutama untuk pasien dengan risiko tinggi.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti pada perawat di RS Prima Husada Sukorejo penatalaksanaan Nyeri Pre Operasi pada Pasien Excisi Tumor Mamae dengan pemberian terapi relaksasi autogenik dan pasien tidak mengetahui Terapi Relaksasi Autogenik.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemberian Terapi Relaksasi Autogenik Terhadap Tingkat Nyeri Pre Operasi pada Pasien Excisi Tumor Mamae Di Ruang IKO di RS Prima Husada Sukorejo.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Benjolan yang terdapat di bagian payudara atau ketiak yang merasa nyeri di area benjolan. Tindakan pre operasi adalah tindakan persiapan operasi. Selama menunggu masuk ke ruang operasi pasien menahan nyeri. Skala nyeri bisa turun dengan diberikan terapi non-farmakologi.

1.2.2 Pertanyaan Masalah

Apakah ada pengaruh pemberian terapi relaksasi autogenik terhadap tingkat nyeri pre operasi pada pasien excisi tumor mamae di ruang IKO di RS Prima Husada Sukorejo?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi relaksasi autogenik terhadap tingkat nyeri pre operasi pada pasien excisi tumor mammae di ruang IKO di RS Prima Husada Sukorejo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tingkat nyeri sebelum terapi relaksasi autogenik pada pre operasi pada pasien excisi tumor mammae di ruang IKO di RS Prima Husada Sukorejo.
2. Mengidentifikasi tingkat nyeri sesudah terapi relaksasi autogenik pada pre operasi pada pasien excisi tumor mammae di ruang IKO di RS Prima Husada Sukorejo.
3. Menganalisis pengaruh pemberian terapi relaksasi autogenik terhadap tingkat nyeri pre operasi pada pasien excisi tumor mammae di ruang IKO di RS Prima Husada Sukorejo.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmiah bagi tenaga keperawatan, sehingga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keperawatan professional.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Bagi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

Memberikan gambaran pengaruh pemberian terapi relaksasi autogenik terhadap tingkat nyeri pre operasi pada pasien excisi

tumor mammae. Suatu terapi non-farmakologi yang dapat dijadikan referensi sebelum tindakan operasi.

2. Bagi STIKes Husada Jombang

Dapat digunakan sebagai tambahan pustaka tentang pengaruh pemberian terapi relaksasi autogenik terhadap tingkat nyeri pre operasi pada pasien excisi tumor mammae.

3. Bagi Perawat

Memberikan wawasan untuk menerapkan penatalaksanaan non-farmakologi pada pasien nyeri pre operasi excisi pada pasien pre operasi tumor mammae.

4. Bagi Responden

Sebagai wacana dan wawasan alternatif untuk pasien agar dapat mengendalikan rasa nyeri secara mandiri dan mengaplikasikan mengurangi rasa nyeri terutama pada pasien pre operasi.

5. Bagi Peneliti

Sebagai acuan dalam menambah wawasan serta meningkatkan pemahaman peneliti tentang pemberian terapi relaksasi autogenik terhadap tingkat nyeri pre operasi pada pasien excisi tumor mammae.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Tumor Mamae

2.1.1 Pengertian Tumor Mamae

Tumor mamae adalah salah satu lesi yang paling dijumpai sehari-hari dan kelainan mammae yang sering terjadi pada wanita (Meliyana & Sirait, 2024). Tumor mamae merupakan pertumbuhan sel-sel yang abnormal yang mengganggu pertumbuhan jaringan tubuh terutama pada jaringan sel epitel di mamae (Lismayanti dkk., 2022).

2.1.2 Klasifikasi Tumor Mamae

Klasifikasi tumor mamae ada 2 jenis menurut Meliyana & Sirait (2024) antara lain:

1. Tumor Mamae Jinak

Tumor payudara jinak merupakan sebagai massa yang tidak membesar atau membesar secara perlahan, yang biasanya berbentuk bulat atau oval dengan tepi halus dan berbatas tegas, dan dapat menunjukkan karakteristik pencitraan spesifik seperti septa internal yang tidak membesar.

2. Tumor Mamae Ganas

Tumor mamae ganas adalah suatu penyakit dimana terjadi pertumbuhan berlebihan atau perkembangan tidak terkontrol dari sel-sel jaringan payudara. Tumor mamae ganas terjadi karena meningkatnya aktivitas proliferasi sel pada payudara dan kelainan yang menurunkan atau kehilangan regulasi kematian sel.

2.1.3 Stadium Tumor Mamae

Stadium tumor mamae ada empat stadium menurut Susilowati dkk (2025) antara lain:

1. Stadium I

Stadium ini memiliki ukuran berdiameter < 2 cm tanpa adanya keterlibatan penyebaran pada limfonodus. Tumor masih terpusat pada area payudara dan tidak ada penyebaran pada organ lainnya. Kemungkinan sembuh sangat tinggi apabila terdeteksi pada stadium I ini tentu saja jika ditangani dengan baik sesuai penatalaksanaan medis yang berlaku.

2. Stadium II

Stadium II dibagi menjadi dua yaitu II A dan II B. Stadium II A masih bersifat lokal. Terdapat ukuran berdiameter 2 cm dengan adanya penyebaran ke limfonodus tetapi penyebaran tidak jauh dan diameter < 5 cm tanpa adanya keterlibatan limfonodus.

Stadium II memiliki ukuran < 5 cm dengan adanya keterlibatan limfonodus atau berukuran > 5 cm tanpa keterlibatan limfonodus dengan penyebaran tidak jauh.

3. Stadium III

Stadium III dibagi menjadi tiga yaitu stadium III A, stadium III B, stadium III C. Stadium III ini ukuran sudah pasti lebih besar dan disertai dengan penyebaran ke organ lain. Stadium III A berukuran > 5 cm dengan keterlibatan limfonodus dan penyebaran

tidak jauh. Stadium III B memiliki tambahan metastasis atau penyebab ke daerah infraklavikula hingga supraklavikula, infiltrasi ke kulit, dinding thorax, hingga menyebabkan edema pada tangan. Stadium III C memiliki ukuran suda berupa-rupa dengan penyebaran lebih luasa ke limfonodus infra dan supraklavikular ipsilateral hingga limfe axilaris.

4. Stadium IV

Stadium ini sudah menjalar ke organ lainnya. Bisa ke paru-paru, tulang belakang, liver, tulang rusuk, dan organ lain. Manifestasi yang tampak pada stadium ini berupa nyeri saja, tetapi bisa juga berupa batuk, sesak nafas, dan pembengkakan.

2.1.4 Etiologi dan Faktor Risiko Tumor Mamae

Etilogi dan faktor risiko tumor mamae menurut Fatimah dkk (2024) antara lain:

1. Etiologi pada tumor mamae adalah faktor genetik, menarche lebih awal, dan menopause lebih terlambat, akan tetapi etiologi tumor payudara tidak diketahui pasti.
2. Faktor risiko tumor mamae adalah umur > 30 tahun, melahirkan anak pertama pada usia > 35 tahun, pernah mengalami infeksi, trauma, pernah menjalani operasi ginekologis, dan kelainan fibrokistik yang ganas.

2.1.5 Manifestasi Klinis Tumor Mamae

Manifestasi klinis tumor mamae menurut Fatimah dkk (2024) antara lain:

1. Terdapat benjolan disalah satu payudara semakin besar.
2. Perubahan puting pada payudara adanya retraksi, sekresi cairan yang tidak biasa, dan ruam dibagian puting.
3. Perubahan dilekukan pada kulit payudara.
4. Tumor mammae yang metastasis memiliki gejala penurunan berat badan, demam, menggigil, nyeri tulang, sakit neurologis.
5. Payudara terasa panas, memerah, dan bengkak.

2.1.6 Komplikasi Tumor Mammae

Beberapa komplikasi pada tumor mammae menurut Nastati (2023) antara lain:

1. Gangguan neurovaskuler.
2. Metastasis (otak, paru-paru, hati, tulang tengkorak, vertebra, iga, dan tulang panjang).
3. Fraktur patologis.
4. Fibrosis payudara.
5. Kematian.

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang Tumor Mammae

Pemeriksaan penunjang pada pasien tumor mammae menurut Nastati (2023) antara lain:

1. Laboratorium yang dicek adalah morfologi sel darah, laju endapan darah, tes faal hati, ter tumor marker dalam serum atau plasma, dan pemeriksaan sitologik.
2. Mammagrafi

Pengujian mammae dengan menggunakan sinar untuk mendeteksi secara dini. Memerlihatkan struktur internal mammae untuk mendeteksi kanker yang tidak teraba atau tumor yang terjadi pada tahap awal. Mammografi pada masa menopause kurang bermanfaat karena gambaran kanker diantara jaringan kelenjar kurang tampak.

3. Ultrasonografi

Ultrasonografi digunakan untuk mendeteksi luka-luka pada daerah padat pada mammae ultrasonography berguna untuk membedakan tumor sulit dengan kista. kadang-kadang tampak kista sebesar sampai 2 cm.

4. Thermography

Thermography untuk mengukur dan mencatat emisi panas yang berasal dari mammae karena peningkatan suplay darah dan penyesuaian suhu kulit yang lebih tinggi

5. Xerodiography

Xerodiography digunakan untuk memberikan dan memasukkan kontras yang lebih tajam antara pembuluh-pembuluh darah dan jaringan yang padat. Menyatakan peningkatan sirkulasi sekitar sisi tumor.

6. Biopsi

Biopsi digunakan untuk menentukan secara menyakinkan apakah tumor jinak atau ganas, dengan cara pengambilan massa.

Memberikan diagnosa definitif terhadap massa dan berguna klasifikasi histogi, pentahapan dan seleksi terapi.

7. CT-Scan

Ct-Scan digunakan untuk diagnosis metastasis carsinoma payudara pada organ lain.

8. Pemeriksaan Hematologi

Pemeriksaan hematologi adalah cara isolasi dan menentukan sel-sel tumor pada speredaran darah dengan sendimental dan sentrifugis darah.

2.1.8 Penatalaksanaan Tumor Mamae

Penatalaksanaa tumor mamae menurut Nastati (2023) antara lain:

1. Pembedahan

- 1) Mastektomi radikal yang dimodifikasi adalah pengangkatan payudara sepanjang nodu limfe axila sampai otot pectoralis mayor. Lapisan otot pectoralis mayor tidak diangkat namun otot pectoralis minor bisa jadi diangkat atau tidak diangkat.
- 2) Mastektomi total adalah semua jaringan payudara termasuk puting dan areola dan lapisan otot pectoralis mayor diangkat.
- 3) Lumpektomi adalah pengangkatan tumor dimana lapisan mayor dri payudara tidak turut diangkat. Exsisi dilakukan dengan sedikitnya 3 cm jaringan payudara normal yang berada di sekitar tumor tersebut.
- 4) Wide excision atau mastektomi parsial adalah exisisi tumor dengan 12 tepi dari jaringan payudara normal, pengangkatan

dan payudara dengan kulit yang ada dan lapisan otot pectoralis mayor.

2. Radioterapi

Radioterapi merupakan kombinasi dari terapi lainnya tapi tidak jarang pula merupakan terapi tunggal. Adapun efek samping: kerusakan kulit di sekitarnya, kelelahan, nyeri karena inflamasi pada nervus atau otot pectoralis, radang tenggorokan.

3. Kemoterapi

Kemoterapi adalah pemberian obat-obatan anti kanker yang sudah menyebar dalam aliran darah. Memiliki efek samping: lelah, mual, muntah, hilang nafsu makan, kerontokan membuat, mudah terserang penyakit.

4. Manipulasi

Manipulasi diberikan obat golongan tamoxifen untuk kanker yang sudah bermetastase, dilakukan bilateral oophorectomy, dan dapat juga digabung dengan terapi endokrin lainnya.

2.2 Konsep Nyeri

2.2.1 Definisi Nyeri

Nyeri adalah suatu sensasi tidak nyaman yang muncul ketika seseorang mengalami cedera atau kerusakan tubuh, maupun potensi kerusakan (Kasrin dkk., 2024). Nyeri merupakan perasaan tidak nyaman yang dialami oleh individu secara subjektif dan yang dapat mempengaruhi pikiran serta mengubah kehidupan sehari-hari (Astuti, 2022).

2.2.2 Klasifikasi Nyeri

Beberapa klasifikasi nyeri menurut Hidayat (2021) antara lain:

1. Klasifikasi nyeri berdasarkan subernya antara lain:

- 1) Nyeri somatik luar adalah perasaan tidak nyaman dengan rangsangan dari kulit, jaringan subkutan dan membran mukosa. Keluhan yang timbul berupa seperti sensasi terbakar, tajam, dan dapat dilokalisasi.
- 2) Nyeri somatik dalam adalah digambarkan sebagai nyeri tumpul (dullness) akibat stimulus pada otot, jaringan ikat, sendi, tulang sehingga tidak dapat dilokalisasi dengan baik.
- 3) Nyeri visceral adalah merespon yang timbul akibat adanya rangsangan pada organ somatik yang menutupinya seperti pleura, parietalis, pericardium, dan peritoneum.

2. Klasifikasi nyeri berdasarkan jenisnya antara lain:

- 1) Nyeri nosiseptif adalah nyeri yang timbul akibat kerusakan jaringan somatic ataupun visceral. Stimulasi nosiseptor akan mengakibatkan tersekresinya mediator inflamasi dari jaringan, sel imun dan ujung saraf sensoris dan simpatik.
- 2) Nyeri neurogenik adalah nyeri akibat adanya disfungsi primer pada sistem saraf perifer seperti lesi pada daerah sekitar saraf perifer. Umumnya penderita akan merasakan seperti ditusuk-tusuk disertai sensasi panas dan tidak mengenakan pada fungsi perabaan.

- 3) Nyeri psikogenik adalah nyeri yang berkaitan dengan adanya gangguan pada kejiwaan seseorang yang direpresentasikan dengan kasus depresi maupun kecemasan.
3. Klasifikasi nyeri berdasarkan waktu antara lain:
 - 1) Nyeri akut memiliki keluhan yang tidak mengengakkan berkaitan dengan kerusakan jaringan dengan durasi mendadak dengan intensitas nyeri ringan hingga berat dan telah dialami penderita $\leq$ 3 bulan.
 - 2) Nyeri kronik mempunyai pengalaman nyeri berkaitan dengan kerusakan aktual maupun fungsional, yang terjadi secara lambat dengan intensitas ringan hingga berat dan konstan yang telah dirasakan selama $\geq$ 3 bulan.
 4. Klasifikasi nyeri berdasarkan derajatnya antara lain:
 - 1) Nyeri ringan dirasakan secara hilang timbul dan pada umumnya terjadi saat melakukan aktivitas sehari-hari.
 - 2) Nyeri sedang timbul secara terus menerus dan menyebabkan terganggunya aktivitas dan dapat hilang saat penderita beristirahat.
 - 3) Nyeri berat dapat terjadi secara menerus sepanjang hari dan menyebabkan penderita tidak mampu beristirahat.

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nyeri

Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri menurut (Raharja & Adab (2025) antara lain:

1. Faktor Biologis

Faktor biologis adalah faktor-faktor yang terkait langsung dengan sistem tubuh manusia dan cara tumbuhan memproses serta merespons nyeri. Beberapa faktor biologis yang mempengaruhi nyeri antara lain:

1) Usia

Usia adalah faktor penting yang mempengaruhi persepsi.

2) Jenis Kelamin

Jenis kelamin dapat mempengaruhi persepsi nyeri. Wanita sering kali melaporkan rasa nyeri yang lebih intens dan lebih sering mengalami nyeri kronis dibandingkan pria. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor hormonal (misalnya estrogen dan progesteron) yang mempengaruhi sensitivitas terhadap nyeri, serta faktor psikologis yang berbeda antara pria dan wanita dalam merespons rasa sakit.

3) Genetik

Genetik juga memainkan peran dalam persepsi nyeri. Beberapa orang mungkin memiliki variasi genetik tertentu yang membuat mereka lebih sensitif terhadap nyeri.

4) Penyakit dan Gangguan Medis

Penyakit tertentu dapat mempengaruhi bagaimana tubuh merasakan nyeri. Kondisi medis seperti diabetes yang menyebabkan neuropati diabetik, arthritis, atau kanker dapat menyebabkan nyeri yang terus-menerus dan meningkatkan kepekaan terhadap rasa sakit.

2. Faktor Psikologis

Faktor psikologis memainkan peran besar dalam pengalaman nyeri dan dapat memperburuk atau mengurangi persepsi nyeri yang dirasakan individu. Beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi nyeri adalah:

1) Kecemasan dan Depresi

Kecemasan dan depresi dapat meningkatkan intensitas nyeri yang dirasakan seseorang. Stres emosional atau kecemasan dapat meningkatkan sensitivitas saraf dan mengurangi toleransi terhadap rasa sakit. Depresi dapat menurunkan ambang batas nyeri, sehingga individu lebih sensitif terhadap sakit.

2) Harapan dan Persepsi

Persepsi nyeri sangat dipengaruhi oleh harapan dan sikap psikologis seseorang terhadap sakit. Seseorang yang berharap akan merasa lebih baik mungkin akan mengalami pengurangan nyeri yang lebih besar.

3) Pengalaman Nyeri Sebelumnya

Pengalaman nyeri sebelumnya juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan nyeri di masa depan. Individu yang pernah mengalami nyeri hebat atau kronis mungkin memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap nyeri berikutnya, karena saraf mereka telah disensitisasi.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya memainkan peran yang sangat penting dalam bagaimana individu merasakan dan memproses nyeri. Beberapa faktor yang mempengaruhi nyeri dari perspektif sosial dan budaya adalah:

1) Norma Sosial dan Budaya

Setiap budaya memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan memrespons nyeri. Dalam beberapa budaya, ada norma sosial yang mengharuskan seseorang untuk menahan nyeri atau tidak mengungkapkannya, sementara di budaya lain, seseorang mungkin merasa lebih bebas untuk mengungkapkannya rasa sakitnya.

2) Dukungan Sosial

Dukungan sosial juga dapat mempengaruhi pengalaman nyeri seseorang. Individu memiliki dukungan sosial yang kuat cenderung melaporkan tingkat nyeri yang lebih rendah, karena adanya bantuan emosional atau praktis yang mereka terima dari keluarga, teman, atau komunitas.

3) Peran Gender dalam Budaya

Banyak budaya memiliki peran gender yang berbeda dalam hal ekspresi nyeri.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat seseorang berada juga dapat mempengaruhi persepsi nyeri. Faktor-faktor seperti suhu,

kelembapan, kebisingan, dan pencahayaan dapat memperburuk atau meredakan nyeri.

2.2.4 Penatalaksanaan Nyeri

Penatalaksanaan nyeri menurut Sarif dkk (2024) antara lain:

1. Terapi Farmakologi

- 1) Non-narkotik dan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID).
- 2) Opiat atau analgesik narkotik (morfin, kodein).
- 3) Obat tambahan (adjuvans) atau koanalgesik.

2. Terapi Non-Farmakologi

1) Bimbingan Antisipasi

Bimbingan antisipasi merupakan kegiatan memberikan pemahaman kepada klien mengenai nyeri yang dirasakan. Pemahaman yang diberikan oleh perawat ini bertujuan memberikan informasi pada klien dan mencegah salah interpretasi tentang peristiwa nyeri.

2) Terapi Kompres Panas dan Kompres Dingin

Terapi kompres dingin dan kompres panas diduga bekerja dengan menstimulasi reseptor tidak nyeri (non-nosiseptor) dalam bidang reseptor yang sama pada cedera. Pemakaian kompres panas biasanya dilakukan hanya setempat saja pada bagian tubuh tertentu sehingga pembuluh darah melebar dan memperbaiki peredaran darah. Sedangkan kompres dingin dapat menurunkan prostatglandin yang memperkuat sensitivitas

reseptor nyeri dan subkutan lain pada tempat cedera dengan menghambat proses inflamasi.

3) Stimulasi Saraf Elektris Transkutan/TENS (*Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation*)

TENS merupakan suatu alat yang menggunakan aliran listrik, baik dengan frekuensi rendah maupun tinggi, yang dihubungkan dengan beberapa elektroda pada kulit untuk menghasilkan sensasi kesemutan, menggetar, atau mendengung pada area nyeri. TENS ialah prosedur noninvasif dan menggunakan metode yang aman untuk mengurangi nyeri, baik akut maupun kronis.

4) Imajinasi Terimbing

Imajinasi terbimbing ialah menggunakan imajinasi seseorang dalam suatu cara yang dirancang secara khusus untuk mencapai efek positif tertentu. Tindakan ini membutuhkan konsentrasi yang cukup.

5) Hypnosis

Hypnosis/hipnosa merupakan sebuah teknik yang menghasilkan suatu kondisi yang tidak sadarkan diri, yang dicapai melalui gagasan-gagasan yang disampaikan oleh orang yang menghipnotisnya. Hipnosis diri sama dengan melamun. Konsentrasi yang intensif mengurangi ketakutan dan stres karena individu berkonsentrasi hanya pada satu pikiran.

6) Massage

Massage yaitu melakukan tekanan tangan pada jaringan lunak, biasanya otot, tendon, atau ligament, tanpa menyebabkan gerakan atau perubahan posisi sendi untuk meredakan nyeri, menghasilkan relaksasi, atau memperbaiki sirkulasi.

7) Relaksasi

Relaksasi merupakan tindakan untuk membebaskan mental dan fisik dari ketegangan dan stress sehingga dapat meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Teknik relaksasi yang sederhana terdiri atas napas abdomen dengan frekuensi lambat, berirama. Metode fisiologis ini dikembangkan untuk melawan ketegangan dan kecemasan. Metode ini merupakan gabungan antara relaksasi dan suatu faktor keyakinan filosofis atau agama yang dianut.

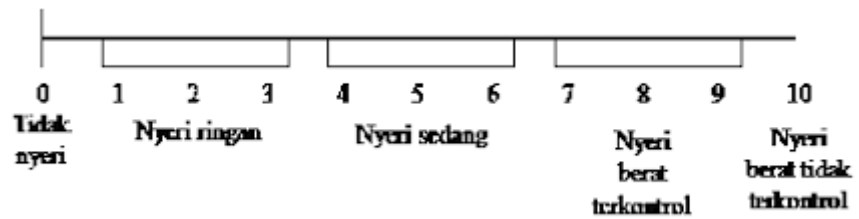
8) Distraksi

Distraksi adalah memfokuskan perhatian pasien pada sesuatu selain nyeri, atau dapat diartikan lain bahwa distraksi adalah suatu tindakan pengalihan perhatian pasien ke hal-hal diluar nyeri. Teknik ini biasanya tidak efektif diberikan pada pasien yang mengalami nyeri berat atau nyeri akut. Hal ini disebabkan pada nyeri berat atau akut, pasien tidak dapat berkonsentrasi dengan baik dan tidak cukup baik untuk ikut serta dalam aktifitas mental dan fisik yang kompleks.

2.2.5 Pengukuran Nyeri

Pengukuran pada nyeri menurut Sarif dkk (2024) antara lain:

1. Skala Intensitas Nyeri Deskriptif Sederhana



Gambar 2.1 Nyeri Deskriptif Sederhana

Skala pendeskripsi verbal (*Verbal Descriptor scale*, VDS) merupakan alat pengukuran tingkat keparahan nyeri yang lebih objektif. Pendeskripsian VDS diranking dari “tidak nyeri” sampai “nyeri yang tidak tertahankan”. Perawat menunjukkan klien skala tersebut dan meminta klien untuk memilih intensitas nyeri terbaru yang ia rasakan. Alat ini memungkinkan klien memilih sebuah kategori untuk mendeskripsikan nyeri.

2. *Numerical Rating Scale* (NRS)



Gambar 2.2 *Numerical Rating Scale*

Numerical Rating Scale (NRS) terdiri dari sebuah garis horizontal yang dibagi secara rata menjadi 10 segmen dengan nomer 0 sampai 10. Pasien diberi tahu bahwa 0 menyatakan “tidak ada nyeri sama sekali” dan 10 menyatakan “nyeri paling parah yang mereka dapat bayangkan”. Pasien kemudian diminta untuk menandai angka yang menurut mereka paling tepat dapat

menjelaskan tingkat nyeri yang mereka rasakan pada suatu waktu. Skala 0 tidak ada rasa nyeri yang dialami, skala 1-3 nyeri ringan, skala 4-6 nyeri sedang, skala 7-9 nyeri berat, dan skala nyeri sangat berat.

3. Skala Intensitas Nyeri *Visual Analog Scale*



Gambar 2.3 *Visual Analog Scale*

Skala analog visual (*Visual Analog Scale*) merupakan suatu garis lurus, yang mewakili intensitas nyeri yang terus menerus dan memiliki alat pendeskripsian verbal pada setiap ujungnya. Dalam perkembangannya VAS menyerupai NRS yang cara penyajiannya diberikan angka 0-10 yang masing-masing nomor dapat menunjukkan intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien.

4. Skala Intensitas Nyeri FLACC

Skala FLACC merupakan alat pengkajian nyeri yang dapat digunakan pada pasien yang secara non verbal yang tidak dapat melaporkan nyerinya.

2.3 Konsep Pre Operasi

2.3.1 Pengertian Pre Operasi

Operasi yaitu tindakan pembedahan pada suatu bagian tubuh. Pre operasi merupakan bagian dari keperawatan perioperatif dan persiapan awal sebelum melakukan tindakan operasi (Hasan dkk.,

2024). Pre operasi yaitu tahapan yang dimulai ketika ada keputusan untuk dilakukan intervensi bedah dan akhir ketika pasien dikirim ke meja operasi (Wihartini, 2022).

2.3.2 Persiapan Pre Operasi

Persiapan dan perawatan pre operasi menurut Hasan dkk (2024) antara lain:

1. Persiapan Mental

Persiapan mental merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam proses persiapan operasi karena mental pasien yang tidak siap atau labil dapat berpengaruh terhadap kondisi fisiknya. Tindakan pembedahan merupakan ancaman potensial maupun aktual pada integritas seseorang yang dapat membangkitkan reaksi stres fisiologis maupun psikologis.

2. Persiapan Fisik

Status kesehatan fisik secara umum dilakukan pengecekan meliputi identitas klien, riwayat penyakit seperti kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga, pemeriksaan fisik lengkap, antara lain status hemodinamika, status kardiovaskuler, status pernafasan, fungsi ginjal dan hepatic, fungsi endokrin, fungsi imunologi, dan lainlain. Selain itu pasien harus istirahat yang cukup karena dengan istirahat yang cukup pasien tidak akan mengalami stres fisik, tubuh lebih rileks sehingga bagi pasien yang memiliki riwayat hipertensi, tekanan darahnya dapat stabil dan pasien wanita tidak akan memicu terjadinya haid lebih awal.

Status nutrisi ditentukan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan, lipat kulit trisep, lingkaran lengan atas, kadar protein darah (albumin dan globulin) dan keseimbangan nitrogen. Segala bentuk defisiensi nutrisi harus dikoreksi sebelum pembedahan untuk memberikan protein yang cukup untuk perbaikan jaringan. Kondisi gizi buruk dapat mengakibatkan pasien mengalami berbagai komplikasi pasca operasi dan mengakibatkan pasien menjadi lebih lama dirawat di rumah sakit.

Keseimbangan cairan perlu diperhatikan *balance* cairan perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan input dan output cairan. Kadar elektrolit serum harus berada dalam rentang normal. Keseimbangan cairan dan elektrolit terkait erat dengan fungsi ginjal. Ginjal berfungsi mengatur mekanisme asam basa dan ekskresi metabolik obat-obatan anastesi. Pencukuran daerah operasi bisa dilakukan atau tidak tergantung daerah mana yang mau dioperasi. Kebersihan tubuh pasien sangat penting untuk persiapan operasi karena tubuh yang kotor dapat merupakan sumber kuman dan dapat mengakibatkan infeksi pada daerah yang dioperasi. Pada pasien yang kondisinya kuat dianjurkan untuk mandi sendiri dan membersihkan daerah operasi dengan lebih seksama. Sebaliknya jika pasien tidak mampu memenuhi kebutuhan *personal hygiene* secara mandiri maka perawat akan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan *personal hygiene*.

3. Sebelum Masuk Kamar Bedah

Persiapan penunjang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tindakan pembedahan. Tanpa adanya hasil pemeriksaan penunjang, maka dokter bedah tidak mungkin bisa menentukan tindakan operasi yang harus dilakukan pada pasien. Pemeriksaan penunjang yang dimaksud adalah berbagai pemeriksaan radiologi, laboratorium maupun pemeriksaan lain seperti EKG, dan lain-lain.

Sebelum dokter mengambil keputusan untuk melakukan operasi pada pasien, dokter melakukan berbagai pemeriksaan terkait dengan keluhan penyakit pasien sehingga dokter bisa menyimpulkan penyakit yang diderita pasien. Setelah dokter bedah memutuskan untuk dilakukan operasi maka dokter anastesi berperan untuk menentukan apakah kondisi pasien layak menjalani operasi. Untuk itu dokter anastesi juga memerlukan berbagai macam pemeriksaan laboratorium terutama pemeriksaan masa perdarahan (*bledding time*) dan masa pembekuan (*clotting time*) darah pasien, elektrolit serum, hemoglobin, protein darah, dan hasil pemeriksaan radiologi berupa foto thoraks dan EKG.

4. Pemeriksaan Status Anestesi

Pemeriksaan status fisik untuk pembiusan perlu dilakukan untuk keselamatan selama pembedahan. Sebelum dilakukan anestesi demi kepentingan pembedahan, pasien akan mengalami pemeriksaan status fisik yang diperlukan untuk menilai sejauh mana resiko pembiusan terhadap diri pasien. Pemeriksaan yang

biasa digunakan adalah pemeriksaan dengan menggunakan metode ASA (*American Society of Anesthesiologist*). Pemeriksaan ini dilakukan karena obat dan teknik anestesi pada umumnya akan mengganggu fungsi pernafasan, peredaran darah dan sistem saraf.

5. Inform Consent

Selain dilakukannya berbagai macam pemeriksaan penunjang terhadap pasien, hal lain yang sangat penting terkait dengan aspek hukum dan tanggung jawab dan tanggung gugat, yaitu Inform Consent. Baik pasien maupun keluarganya harus menyadari bahwa tindakan medis, operasi sekecil apapun mempunyai resiko. Oleh karena itu setiap pasien yang akan menjalani tindakan medis, wajib menuliskan surat pernyataan persetujuan dilakukan tindakan medis (pembedahan dan anestesi). Inform Consent sebagai wujud dari upaya rumah sakit menjunjung tinggi aspek etik hukum, maka pasien atau orang yang bertanggung jawab terhadap pasien wajib untuk menandatangani surat pernyataan persetujuan operasi.

2.4 Konsep Terapi Relaksasi Autogenik

2.4.1 Pengertian Terapi Relaksasi Autogenik

Terapi relaksasi autogenik adalah terapisteknik relaksasi diri melalui pengulangan kalimat afirmatif positif yang memengaruhi sistem saraf otonom untuk mencapai kondisi tenang dan rileks. Metode ini membantu pasien memusatkan perhatian pada sensasi tubuh, seperti rasa hangat dan berat di ekstremitas, sehingga menurunkan ketegangan otot dan respon stress (Atmojo, 2023). Terapi relaksasi autogenik

adalah relaksasi dari diri sendiri dengan menggunakan kata-kata atau kalimat pendek yang bisa membuat pikiran menjadi tenang (Hati dkk., 2023).

2.4.2 Tujuan Terapi Relaksasi Autogenik

Tujuan terapi relaksasi autogenik menurut Atmojo (2023) antara lain:

1. Menurunkan kecemasan.
2. Mengurangi skala nyeri.
3. Meningkatkan kualitas tidur.
4. Menurunkan tekanan darah.

2.4.3 Manfaat Terapi Relaksasi Autogenik

Manfaat dari terapi relaksasi autogenik menurut Atmojo (2023) antara lain:

1. Mengurangi rasa nyeri.
2. Menurunkan tekanan darah.
3. Menurunkan kecemasan.
4. Meningkatkan kualitas nyeri.
5. Mengurangi kelemahan.

2.4.4 Indikasi dan Kontraindikasi Terapi Relaksasi Autogenik

Indikasi dan kontraindikasi terapi relaksasi autogenik menurut Atmojo (2023) antara lain:

1. Indikasi Terapi Relaksasi Autogenik
 - 1) Respon verbal yang dimiliki pasien mengatakan rileks, ketegangan berkurang, dan sudah merasa nyaman.
 - 2) Respon non-verbal tampak tenang, ekspresi wajah pasien tampak tegang, dan tanda-tanda vital dalam batas normal.

2. Kontraindikasi Terapi Relaksasi Autogenik

- 1) Relaksasi autogenik tidak dianjurkan untuk anak dibawah 5 tahun.
- 2) Individu yang kurang motivasi atau individu yang memiliki masalah yang berat.

2.4.5 Prosedur Terapi Relaksasi Autogenik

Prosedur terapi relaksasi autogenik menurut Atmojo (2023) antara lain:

1. Pasien dipandu untuk menarik napas perlahan melalui hidung, lalu tahan 2 detik, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut.
2. Pasien dipandu membayangkan rasa berat di tangan dan kaki.
“Tangan kanan saya terasa berat... tangan kiri saya terasa berat... kaki kanan saya terasa berat... seluruh tubuh saya terasa berat dan rileks.”
3. Pasien dipandu untuk membayangkan kehangatan di anggota tubuh.
“Tangan kanan saya terasa hangat... tangan kiri saya terasa hangat... kehangatan menyebar ke seluruh tubuh saya.”
4. Pasien dipandu untuk menyadari detak jantungnya. “Jantung saya berdetak dengan tenang dan teratur.”
5. Pasien dipandu merasakan napasnya tertur. “Pernapasan saya tenang dan teratur... udara masuk dan keluar dengan lembut.”
6. Pasien diajak merasakan kehangatan diperut. “Perut saya terasa hangat dan nyaman.”

7. Pasien dipandu untuk membayangkan kesejukan pada dahi untuk menenangkan pikiran. “Dahi saya terasa sejuk dan tenang... pikiran saya jernih dan damai.”

2.5 Pengaruh Pemberian Terapi Relaksasi Autogenik Terhadap Tingkat Nyeri Pre Operasi pada Pasien Excisi Tumor Mamae

Tumor mamae merupakan hasil dari proses pertumbuhan sel epitel payudara yang abnormal akibat terjadinya gangguan pada mekanisme pengaturan proliferasi dan diferensiasi sel. Tumor mamae ada beberapa tahap yaitu tahap inisiasi karena kerusakan DNA akibat faktor genetik dan lingkungan. Tahap promosi ini terdapat sel yang telah mengalami mutasi berkembang biak secara tidak terkendali. Aktivitas ini meningkatkan ekspresi gen yang berkaitan dengan pembelahan sel hingga jumlah sel abnormal bertambah. Tahap angiogenik merupakan tahap yang ada proses angiogenesis dan metastasis (Nurmalasari, 2025).

Proses nyeri memiliki empat tahap yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi nyeri. Pada tahap transduksi memiliki rangsangan seperti luka atau tekanan diubah menjadi impuls listrik oleh reseptor nyeri (nosiseptor). Impuls ini kemudian dihantarkan ke medula spinalis dan otak melalui serabut saraf A-delta dan C. Sistem saraf pusat dapat menekan atau memperkuat impuls nyeri melalui mekanisme modulasi yang melibatkan endorfin dan enkefalin sebagai penghambat alami. Tahap persepsi adalah ketika impuls nyeri disadari oleh otak sebagai sensasi tidak nyaman. Persepsi nyeri ini bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh faktor psikologis, emosional, dan pengalaman individu sebelumnya (Jamal, 2022).

Mekanisme pada terapi relaksasi autogenik ini didasarkan pada kemampuan tubuh untuk mengatur fungsi fisiologis melalui pengaruh pikiran terhadap sistem saraf otonom. Saat seseorang melakukan latihan autogenik dengan fokus pada sensasi hangat dan berat pada tubuh, terjadi penurunan aktivitas sistem saraf simpatis dan peningkatan aktivitas sistem saraf parasimpatis. Hal ini menyebabkan penurunan denyut jantung, tekanan darah, dan ketegangan otot, serta peningkatan aliran darah perifer. Pemberian terapi relaksasi autogenik dapat menurunkan nyeri (Atmojo, 2023).

2.6 Keaslian Penelitian

No	Judul	Intervention	Comparison	Outcome	Time
1	Autogenic Relaxation Therapy for Preoperative Anxiety and Pain Management in Surgical Patients: A Randomized Controlled Trial (2023)	Terapi Relaksasi Autogenik	Tidak dilakukan	Studi RCT pada 120 pasien bedah umum menunjukkan ART menurunkan nyeri preoperatif hingga 35% (skala VAS) dan kecemasan, dibandingkan kelompok kontrol. Intervensi ART harian sebelum operasi. Efek signifikan ($p < 0.01$) didukung oleh pengukuran biomarker stress.	Penelitian dilakukan 3 sesi dengan durasi 10-20 menit
2	Effectiveness of Autogenic Training in Reducing Preoperative Pain and Anxiety in Elective Surgery (2022)	Terapi Autogenik	Tidak ada	Penelitian pada 80 pasien laparoskopi menemukan ART mengurangi nyeri subjektif preoperatif sebesar 28% ($p < 0.05$) melalui latihan relaksasi otomatis.	Penelitian dilakukan 1 hari sekali dengan durasi 15-20 menit
3	Pengaruh Akupresur dan Relaksasi Autogenik	Akupresur dan Relaksasi Autogenik	Tidak ada	penelitian antara kelompok eksperimen (Kombinasi	Terapi ini diberikan 2 kali perlakuan

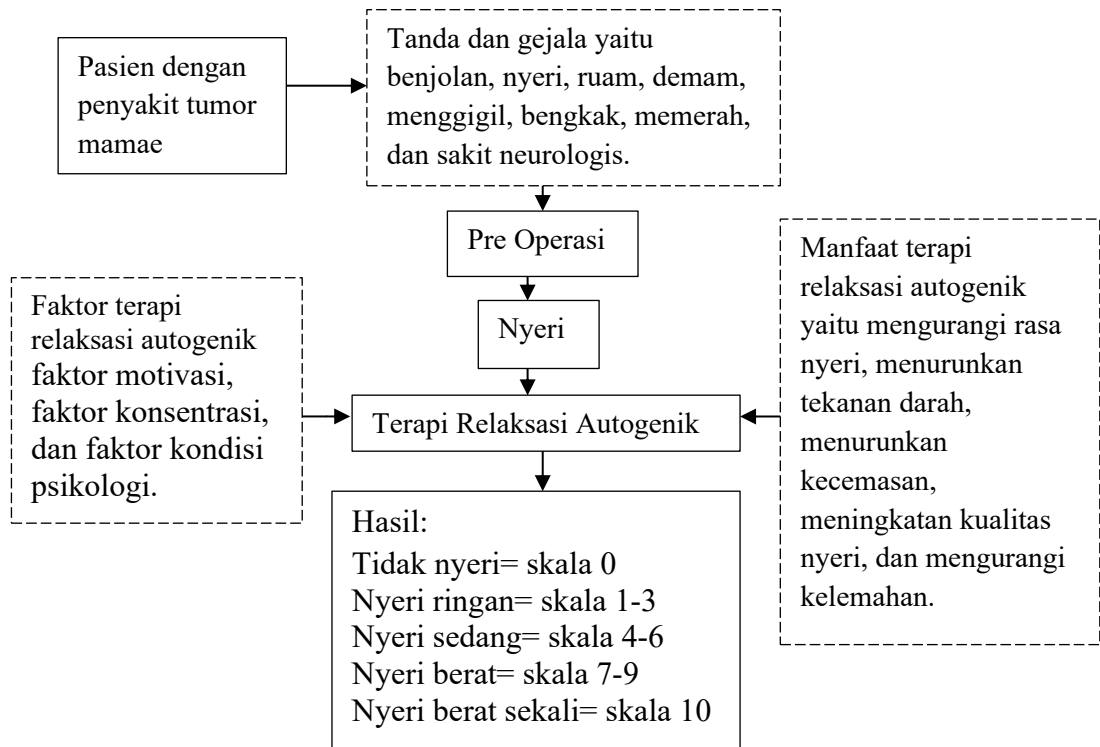
	Terhadap Tekanan Darah dan Tingkat Nyeri Penderita Hipertensi (2023)			akupresur dan relaksasi autogenik) dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 nilai $p < 0,005$.	dengan durasi 20 menit.
--	--	--	--	--	-------------------------

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep

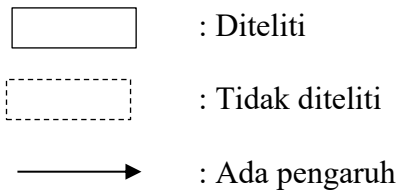
Kerangka konsep yaitu uraian konseptual mengenai hubungan antar konsep atau variabel yang disusun berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, serta pengalaman peneliti, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti (Nursalam, 2020).



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

Pasien yang mengalami penyakit tumor mammae memiliki tanda dan gejala antara lain benjolan, nyeri, ruam, demam, menggigil, bengkak, memerah, dan sakit neurologis. Penatalaksanaan pada penyakit tumor mammae dilakukan operasi. Sebelum dilakukan operasi pasien mengalami nyeri, sehingga pasien diberikan terapi relaksasi untuk menurunkan nyeri agar skala nyeri menjadi dari berat ke ringan.

Keterangan:



3.2 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka konseptual tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: ada pengaruh pemberian terapi relaksasi autogenik terhadap tingkat nyeri pre operasi pada pasien excisi tumor mammae di ruang IKO di RS Prima Husada Sukorejo, dengan nilai signifikan H1 bila $> 0,05$.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Suatu desain penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap suatu variabel, namun tidak dilakukan pengacakan dalam penentuan subjek penelitian disebut *Quasi experiment* (Nursalam, 2020). Rancangan penelitian ini menggunakan *pretest-posttest one group design* yakni terdapat satu kelompok yaitu kelompok perlakuan.

Sebelum memberikan perlakuan untuk dilakukan pengukuran nyeri dengan kuesioner NRS. Setelah pengukuran nyeri diberikan terapi relaksasi autogenik dengan durasi 15 menit. Setelah pemberian terapi ini dilakukan pengukuran nyeri dengan kuesioner NRS. Penelitian ini bertujuan pengaruh pemberian terapi relaksasi autogenik terhadap tingkat nyeri pre operasi pada pasien excisi tumor mammae di ruang IKO di RS Prima Husada Sukorejo.

Tabel 4.1 Skema One-Group Pretest-Posttest Design

Pre test	Treatment	Post test
X1	Y (Terapi non-farmakologi)	X2

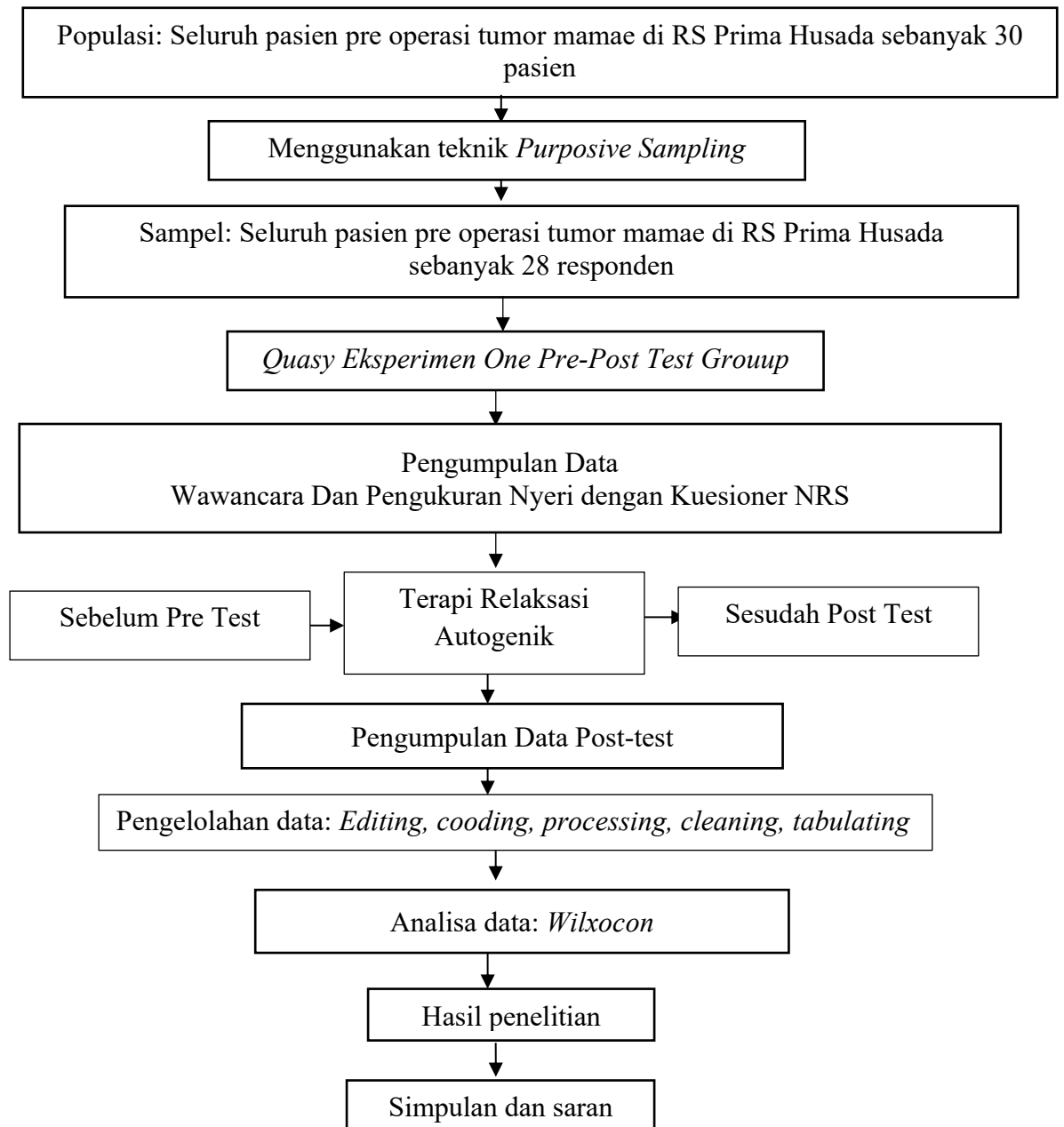
Keterangan:

X1 : Kelompok intervensi sebelum diberikan terapi non-farmakologi.

X2 : Kelompok intervensi sesudah diberikan terapi non-farmakologi.

Y : Terapi non-farmakologi.

4.2 Kerangka Kerja



Gambar 4.2 Kerangka Kerja

4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

4.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Notoatmodjo, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien dengan tumor mammae yang melakukan pre operasi di ruangan IKO rumah sakit Prima Husada Sukorejo pada bulan September 2025 sebanyak 30 orang.

4.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu dan mewakili keseluruhan populasi (Notoatmodjo, 2020). Sampel dalam penelitian ini adalah pasien tumor mammae dengan jumlah semua sampel sebanyak 28 responden.

$$n_0 = \frac{Z^2 p(1-p)}{d^2}$$

$$n = \frac{n_0}{1 + (n_0 - 1) : N}$$

$$n_0 = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times 0,5}{0,05^2} = 384,16$$

$$n = \frac{384,16}{1 + (384,16 - 1) : 30} = 27,8 = 28$$

Adapun kriteria inklusi dan kriteri eksklusi antara lain:

1. Kriteria Inklusi

- 1) Responden terdiagnosa tumor mammae stadium II.
- 2) Responden tidak memiliki penyakit penyerta.
- 3) Skala nyeri berat.
- 4) Responden tidak meminum obat nyeri.

2. Kriteria Eksklusi

- 1) Responden mengalami nyeri sangat berat.
- 2) Responden tidak kooperatif.
- 3) Usia responden 70 tahun ke atas.

4.3.3 Teknik Sampling

Teknik sampling pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2020).

4.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

4.4.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau diduga menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen (Nursalam, 2020). Variabel *independent* dalam penelitian ini adalah nyeri pre operasi pasien excisi tumor mammae.

4.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel independen. Variabel ini sering disebut juga variabel terikat, karena nilainya tergantung pada perubahan yang terjadi pada variabel independent (Notoatmodjo, 2020). Variabel *dependent* pada penelitian ini adalah terapi relaksasi autogenik.

4.4.3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi suatu variabel dengan cara memberikan spesifikasi kegiatan, dan variabel tersebut dapat diukur secara nyata (Notoatmodjo, 2020).

Tabel 4.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Parameter	Alat Ukur	Skala	Skoring dan Kriteria
Independen: nyeri nyeri pre operasi pasien excisi tumor mameae	Tingkat rasa nyeri yang dialami pasien tumor mameae	Parameter nyeri: durasi, intensitas, frekuensi, lokasi	Kuesioner NRS Sarif dkk (2024)	Ordinal	Skor: 1. Skor 0 tidak nyeri 2. Skor 10 nyeri berat Kriteria penilain: Tidak nyeri: skala 0 Nyeri ringan: skala 1-3 Nyeri sedang: skala 4-6 Nyeri berat: skala 7-9 Nyeri sangat berat: skala 10
Dependen: terapi relaksasi autogenik	Salah satu teknik relaksasi yang berfokus pada sugesti diri untuk menimbulkan sensasi rileks melalui konsentrasi terhadap sensasi tubuh seperti kehangatan, berat, dan pernapasan teratur, sehingga menurunkan ketegangan otot dan respon stres fisiologis.	Merasakan pernapasan, sensai hangat, berat lengan, dan perasaan rileks	Memakai SOP dan Lembar Observasi	-	-

4.5 Bahan Penelitian

Penelitian ini memerlukan bahan-bahan, yaitu komputer atau laptop untuk mengerjakan coding data pasien, bulpen untuk mencatat data-data pasien, lembar data responden, lembar kuesioner nyeri, dan standar operasional prosedur pelaksanaan terapi relaksasi. Variabel nyeri membutuhkan kuesioner NRS untuk mengukur skala nyeri dan variabel relaksasi autogenik membutuhkan SOP.

4.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah variabel dependen terapi relaksasi autogenik menggunakan SOP. Pengukuran variabel independen nyeri pre operasi pasien excisi tumor mammae menggunakan kuesioner NRS dan kuesioner data responden. Pengukuran nyeri yaitu kuesioner NRS. Pengukuran nyeri ini ada tingkat nyeri yaitu skor 0 tidak ada nyeri, skor 1-3 nyeri ringan, skor 4-6 nyeri sedang, skor 7-9 nyeri berat, dan skor 10 nyeri sangat berat.

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di ruangan IKO rumah saki Prima Husada Sukorejo. Waktu ambil data dibulan September dan penelitian dilakukan pada bulan Desember 2025.

4.8 Prosedur Pengambilan Data dan Penelitian

Prosedur pengambilan data dan penelitian memerlukan langkah-langkah sebagai berikut ini:

1. Penelitian menyusun proposal penelitian yang mencakup latar belakang, tujuan, metode, kerangka teori, dan instrumen penelitian. Proposal ini kemudian diajukan ke dosen pembimbing untuk dikaji dan disetujui.

2. Setelah proposal mendapat persetujuan awal dari dosen pembimbing, penelitian mengajukan surat studi pendahuluan, kemudian diberikan kepada SDM rumah sakit Prima Husada Sukorejo, dan mendapat balasan dari SDM rumah sakit Prima Husada Sukorejo.
3. Setelah melakukan ujian proposal, peneliti melakukan uji etik di kampus STIKes Husada Jombang.
4. Setelah itu peneliti meminta surat izin penelitian ke kampus STIKes Husada Jombang, kemudian diberikan kepada SDM rumah sakit Prima Husada Sukorejo.
5. Setelah mendapat surat balasan dari SDM rumah sakit Prima Husada Sukorejo, peneliti membawa surat tersebut ke ruangan IKO untuk diberikan ke kepala ruangan IKO.
6. Setelah mendapatkan izin dari kepala ruangan IKO peneliti mengambil dan melakukan penelitian.
7. Prosedur Penelitian
 - 1) Peneliti mendapatkan data responden pre operasi tumor mammae di ruang IKO rumah sakit Prima Husada.
 - 2) Penelitian ini dilakukan dengan 1 teman untuk membantu penelitian.
 - 3) Peneliti memberikan lembar persetujuan menjadi responden, setelah itu dikumpulkan ke peneliti.
 - 4) Setelah itu peneliti mengukur skala nyeri responden menggunakan kuesioner NRS.

- 5) Kemudian peneliti memberikan terapi relaksasi autogenik pada responden yang mengalami nyeri pre operasi tumor mammae. Terapi ini diberikan dengan durasi 15 menit 1 kali pemberian.
- 6) Setelah pemberian terapi peneliti mengukur skala nyeri responden.
- 7) Penelitian ini dilakukan 1 hari 3 responden. Penelitian dilakukan selama 10 hari. Hari pertama dan kedua 2 responden, hari ketiga sampai terakhir 3 responden. Pemberian terapi diberikan 1 kali dalam pertemuan dan langsung diukur skala nyeri post test.

4.9 Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini antara lain *editing*, *coding*, *scoring*, dan tabulating.

1) Editing

Tahap editing merupakan salah satu proses untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, sehingga memastikan kelengkapan, dan konsistensi data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut (Nursalam, 2020).

2) Coding

Tahap coding yaitu suatu proses yang memberi kode berupa angka terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori (Nursalam, 2020).

1. Data Umum

1) Jenis Kelamin

Perempuan : 1

Laki-laki : 2

2) Usia

25-30 tahun : 1

31-40 tahun : 2

41-45 tahun : 3

3) Pendidikan

SD : 1

SMP : 2

SMA : 3

4) Riwayat Operasi

Operasi pertama kali : 1

Operasi lebih dari 1 kali : 2

5) Lama Menderita Penyakit

6 bulan-1 tahun : 1

1 tahun-3 tahun : 2

6) Pekerjaan

IRT : 1

Pedagang : 2

Karyawan : 3

2. Data Khusus

Skor 0 tidak ada nyeri : 1

Skor 1-3 nyeri ringan : 2

Skor 4-6 nyeri sedang : 3

Skor 7-9 nyeri berat : 4

Skor 10 nyeri sangat berat : 5

3) Scoring

Tahap scoring adalah proses pemberian skor atau nilai numerik terhadap data yang telah dikodekan (Nursalam, 2020).

Skor skala nyeri antara lain:

Skor 0 tidak ada nyeri : 1

Skor 1-3 nyeri ringan : 2

Skor 4-6 nyeri sedang : 3

Skor 7-9 nyeri berat : 4

Skor 10 nyeri sangat berat : 5

4) Tabulating

Tahap tabulating adalah proses penyusunan dan penghitungan data yang telah diberi skor ke dalam bentuk table (Nursalam, 2020).

2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen benar-benar menggambarkan variabel yang diteliti. Uji reliabilitas adalah tingkat konsistensi suatu instrumen penelitian apabila digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian menghasilkan data yang stabil, konsisten, dan dapat dipercaya (Nursalam, 2020).

Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini tidak dilakukan karena penelitian ini untuk pengukuran nyeri dalam penelitian dengan menggunakan kuesioner NRS.

4.10 Uji Univariat dan Bivariat

Analisa univariat adalah analisa dilakukan terhadap variabel hasil penelitian, hasil analisa distribusi, dan presentase dari tiap variabel tanpa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisa univariat pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan distribusi dan presentase dari variabel sebelum dilakukan terapi relaksasi autogenik dan sesudah dilakukan terapi relaksasi autogenik.

Penelitian ini dilakukan untuk pengukuran uji normalitas menggunakan uji *Shapiro-Wilk*. Jika *p*-value lebih besar dari 0,05 data dianggap berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau variansnya tidak normal, dilakukan uji non-parametrik seperti *Wilcoxon*. Uji *Wilcoxon* digunakan untuk membandingkan nilai pre-test dan post-test. Jika *p*-value < 0,05, hipotesis nol (H_0) ditolak, yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

4.11 Masalah Etik

Masalah etik adalah situasi atau kondisi di mana seseorang dihadapkan pada dua atau lebih pilihan tindakan yang sama-sama memiliki nilai moral, namun tidak semuanya dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga menimbulkan konflik moral dalam pengambilan keputusan (Notoatmodjo, 2020). Prinsip-prinsip masalah etik antara lain:

1. Persetujuan Responden

Sebelum melakukan penelitian, peneliti memberikan penjelasan mengenai manfaat dan tujuan penelitian secara jelas kepada responden tentang penelitian yang akan dilakukan. Jika responden setuju maka diminta untuk mengisi lembar persetujuan, menandatangani, dan sebaliknya jika responden tidak bersedia dalam penelitian ini, maka peneliti tetap menghormati hak-hak responden.

2. Tanpa Nama

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak mencantumkan nama responden pada lembar pengkajian dan hanya menuliskan kode atau inisial pada lembar pengumpulan data serta hasil penelitian yang akan disajikan.

3. Kerahasiaan

Kerahasiaan dalam penelitian merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.

4. Manfaat (*Beneficence*)

Prinsip etik beneficence dalam penelitian adalah kewajiban membantu orang lain dengan mengupayakan manfaat maksimal dan kerugian minimal. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan intervensi untuk memberikan manfaat kepada responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, A. A. R., Dwimartyono, F., Maharani, R. N., Harahap, M. W., & Khalid, N. F. (2024). Efektivitas Premedikasi Ibuprofen IV terhadap Skala Nyeri dan Efek Samping Pasca Bedah Tumor Mammae. *UMI Medical Journal*, 9(1), 31–40.
- Astuti, R. K. (2022). Studi Deskriptif Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Penanganan Nyeri. *Intan Husada: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 10(02), 75–82.
- Atmojo, P. B. (2023). Pengaruh Terapi Relaksasi Autogenic terhadap Tingkat Kecemasan pada Pasien Pre Operasi di Ruang Rawat Inap RS Medistra Tahun 2022. *Jurnal Interprofesi Kesehatan Indonesia*, 2(3), 347–353.
- Bachtiar, S. M. (2022). *Penurunan Intensitas Nyeri Pasien Kanker Payudara dengan Teknik Guided Imagery*. Jakarta: Penerbit NEM.
- Cahyawati, T. D., & Wedayani, A. A. A. N. (2024). Pengabdian Masyarakat Pelaksanaan Skrining Tumor Payudara. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(2), 561–566.
- Dinkes Jatim. (2024). *PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR*. Surabaya: Dinas Kesehatan Jawa Timur
- Fatimah, Ismail, N. F., Masrochah, S., Dartini, Darmini, Aryani, A. I., Ali, A., & Nasir, F. M. (2024). *PENCITRAAN DIAGNOSTIK WANITA : PRINSIP, PATOLOGI UMUM DAN MODALITAS IMEJING*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Febriyona, R., Sudirman, A. N. A., & Hadji, A. (2025). Pengaruh Terapi Kompres Es terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Punggung Bawah pada Pekerja Kerawang Desa Mongoloto Kecamatan Telaga. *Malahayati Nursing Journal*, 7(3), 1201–1213.
- Hafsah, L. (2022). Gambaran tingkat kecemasan pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. *Jurnal Vokasi Keperawatan (JVK)*, 5(2).
- Hasan, N. S., Agustriyani, F., & Susanto, A. (2024). Pengaruh Edukasi Tindakan Phacomulsifikasi terhadap Tingkat Kecemasan pada Pasien Pre-Op Katarak di Rumah Sakit Mata LEC. *Health Research Journal of Indonesia*, 2(5), 307–312.
- Hati, Y., Muchsin, R., & Tamara, B. (2023). Terapi relaksasi autogenik untuk menurunkan nyeri post operasi TURP pada pasien BPH. *Jurnal Keperawatan Priority*, 6(2), 85–91.

- Hidayat, A. A. (2021). *Dokumentasi Keperawatan; Aplikasi Praktik Klinik*. Health Books Publishing.
- Jamal, F. (2022). Penilaian dan modalitas tatalaksana nyeri. *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, 5(3), 66–73.
- K. Tanaka. (2024). Autogenic Relaxation Interventions for Preoperative Pain and Anxiety: An Updated Systematic Review. *Pain Management Nursing*, 25(1), 45–55.
- Kasrin, R., Jafri, Y., Hamdi, I., & Afifah, S. (2024). Manajemen Nyeri Non Farmacologi Dengan Teknik Relaksasi Dan Kompres Air Hangat. *PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 2(01), 47–57.
- Lismayanti, L., Gandiny, E. D., Fitriani, A., & Srinayanti, Y. (2022). Teknik Relaksasi untuk Menurunkan Kecemasan pada Pasien Pre-post Operasi Tumor Mammae Sinistra. *Indogenius*, 1(2), 58–66.
- M. Zhang. (2022). Effectiveness of Autogenic Training in Reducing Preoperative Pain and Anxiety in Elective Surgery. *ournal of Perioperative Nursing*, 37(3), 150–158.
- Meliyana, E., & Sirait, L. I. (2024). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Penerbit NEM.
- Nastati, D. A. (2023). *ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. Y DENGAN DIAGNOSIS MEDIS CA MAMAE DEXTRA POST MASTEKTOMI HARI KE 1 DI RUANG G2 RSPAL dr. RAMELAN SURABAYA*.
- Nor, L. (2024). *PENGARUH PEER GROUP SUPPORT TERHADAP KUALITAS HIDUP PASIEN KANKER PAYUDARA YANG MENJALANI KEMOTERAPI DI RUMAH SAKIT TK II DR. SOEDJONO MAGELANG*.
- Notoatmodjo, S. (2020). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhanifah, D., & Sari, R. T. (2022). *Manajemen nyeri nonfarmakologi*. Jawa Barat: UrbanGreen Central Media.
- Nurmalasari, M. (2025). *PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN PRE OPERASI INSISI TUMOR MAMAE DI RAWAT INAP LANTAI 7B RS PUSAT PERTAMINA*.
- Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis Edisi ke-5*. Jakarta: Salemba Medika.
- Raharja, E., & Adab, P. (2025). *Nyeri Dalam Perspektif Keperawatan: Teori, Praktik, dan Inovasi*. Malang: Penerbit Adab.
- Rekam Medis RSPH. (2025). *Jumlah Pasien Hipertensi di RS Prima Husada Sukorejo*.

- Renita, J., Kurniyati, & Puspita, Y. (2023). PENGARUH METODE CERAMAH KOMBINASI MEDIA LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR TENTANG PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PASAR KEPAHANG TAHUN 2023. *Journal Of Midwifery*, 11(2), 265–271.
- Sarif, P. S., Era, D. P., & Arsyawina, A. (2024). *ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN APENDISITIS DENGAN MASALAH KEPERAWATAN NYERI AKUT DI RUANG ENGGANG 3 RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT TENGGARONG*.
- Subiyakto, M. H., & Ariyani, A. (2024). PENGARUH TERAPI RELAKSASI AUTOGENIK TERHADAP TINGKAT KECEMASAN DAN TEKANAN DARAH PASIEN PRE-OPERASI DI RUANG MAWAR 3 RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 83–90.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Supriyanto, A., Kusuma, W. A., & Rahmawan, H. (2022). Klasifikasi Kanker Tumor Payudara Menggunakan Arsitektur Inception-V3 Dan Algoritma Machine Learning. *J. Al-AZHAR Indones. SERI SAINS DAN Teknol*, 7(3), 187.
- Susilowati, Y. A., Nugroho, F. C., Fadilah, A., & Suryani, D. (2025). *BUKU REFERENSI PENTINGNYA PERAWATAN PASIEN KANKER PAYUDARA. Optimal Untuk Negeri*.
<https://books.google.co.id/books?id=XDeDEQAQBAJ>
- Virnanda, V. A. (2025). *Pengaruh Pemberian Terapi Kompres Dingin (Cryotherapy) Terhadap Skala Nyeri Pada Pasien Pasca Operasi Abdomen*.
- Wihartini. (2022). *PENGARUH EDUKASI KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PASIEN PRE OPERASI ELEKTIF DI RSUPN DR. CIPTO MANGUNKUSUMO*.

LAMPIRAN

Lampiran Jadwal Penyusunan Skripsi Mahasiswa
Jadwal Penyusunan Skripsi Mahasiswa

Tahun Akademik 2025

NO	KEGIATAN	Juli 2025	Agustus 2025	September 2025	Oktober 2025	November 2025
1	PEMBAGIAN PEMBIMBING DAN BUKU PEDOMAN					
2	PENGAJUAN JUDUL					
3	STUDI PENDAHULUAN (SURAT PERMOHONAN)					
4	BAB 1					
5	BAB 2					
6	BAB 3					
7	BAB 4					
8	UJIAN PROPOSAL					
9	PELAKSANAAN PENELITIAN					
10	KONSUL HASIL PENELITIAN DAN PENDAAAN					
11	PENYUSUNAN BAB 5					
12	BAB 6					
13	BAB 7					
14	KELENGKAPAN LAMPIRAN DAN SKRIPSI					
15	UJIAN HASIL SKRIPSI					
16	PENYERAHAN SKRIPSI					

Lampiran Penjelasan Sebelum Persetujuan

PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Farid Wahyudi Antok

NIM : 2024030262

Status : Mahasiswa S1 Keperawatan STIKes Husada Jombang

Judul Penelitian : Pengaruh Pemberian Terapi Relaksasi Autogenik
Terhadap Tingkat Nyeri Pre Operasi pada Pasien Excisi
Tumor Mamae Di Ruang IKO di RS Prima Husada
Sukorejo

Berikut ini saya menjelaskan beberapa hal terakit dengan penelitian yang akan saya lakukan:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi relaksasi autogenik terhadap tingkat nyeri pre operasi pada pasien excisi tumor mamae di ruang IKO di RS Prima Husada Sukorejo
2. Responden pada penelitian ini adalah pasien pre operasi tumor mamae di ruang IKO rumah sakit Prima Husada Sukorejo.
3. Jika merasa tidak nyaman selama penelitian, responden dapat memberitahu peneliti.
4. Partisipasi bersifat sukarela dan responden berhak menghentikan keikutsertaan kapan saja.
5. Semua data akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.
6. Responden akan diminta memberikan penilaian nyeri menggunakan skala nyeri 0-10 sebelum dan sesudah terapi, kemudian mencatat dilembar observasi.
7. Setealah itu peneliti memberikan terapi relaksasi autogenik.

Jombang,.....2025

Peneliti

(Farid Wahyudi Antok)

Lampiran Lembar Permohonan Menjadi Responden

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Saya sebagai mahasiswa program S1 Keperawatan STIKes Husada Jombang, menyatakan bahwa saya mengadakan penelitian ini sebagai salah satu kegiatan untuk memenuhi tugas akhir Studi Keperawatan STIKes Husada Jombang.

Tujuan ini untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi relaksasi autogenik terhadap tingkat nyeri pre operasi pada pasien excisi tumor mammae di ruang IKO di RS Prima Husada Sukorejo. Sehubungan dengan hal tersebut diatas saya mengharapkan kesediaan responden untuk memberikan jawaban dan tanggapan. Saya menjamin kerahasiaan pendapat, identitas, dan informasi yang anda berikan hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu keperawatan dan tidak digunakan untuk maksud lain.

Partisipan anda dalam penelitian ini bersifat bebas artinya anda bebas ikut atau tidak ikut tanpa sanksi apapun. Atas perhatian dan ketersediaannya saya ucapkan terimakasih.

Jombang,.....2025

Peneliti

Responden

(Farid Wahyudi Antok)

(.....)

Lampiran Lembar Persetujuan Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

INFORMED CONSENT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Telah mendapatkan penjelasan dan keterangan secara jelas dan terperinci mengenai penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberian Terapi Relaksasi Autogenik Terhadap Tingkat Nyeri Pre Operasi pada Pasien Excisi Tumor Mamae Di Ruang IKO di RS Prima Husada Sukorejo”.

1. Perlakuan yang akan ditempatkan pada subyek.
2. Manfaat sebagai subyek penelitian dan prosedur penelitian.

Responden penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia secara sukarela untuk menjadi responden penelitian dengan penuh kesadaran tanpa adanya keterpaksaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Jombang,.....2025

Peneliti

Responden

(Farid Wahyudi Antok)

(.....)

Lampiran Lembar Kuesioner Umum Demografi

LEMBAR KUESIONER DATA UMUM DEMOGRAFI

Isilah tanda yang kosong, berilah tanda centang bagian yang sesuai.

Nama Inisial :

Lokasi :

Kode Responden :

Data Umum Responden:

1. Jenis Kelamin : () Laki-laki () Perempuan

2. Usia :

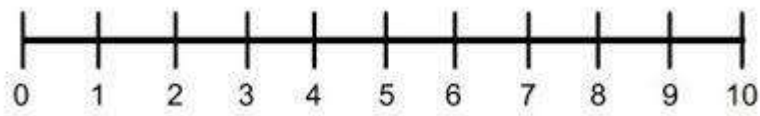
3. Pendidikan :

4. Pekerjaan :

5. Mendapat informasi tentang terapi relaksasi autogenik.

() Tidak () Ya

Data Khusus Responden:



1. Skala Nyeri Sebelum Intervensi

() Tidak Nyeri : Skala 0

() Nyeri Ringan : Skala 1-3

() Nyeri Sedang : Skala 4-6

() Nyeri Berat : Skala 7-9

() Nyeri Sangat Berat : Skala 10

2. Skala Nyeri Sesudah Intervensi

() Tidak Nyeri : Skala 0

() Nyeri Ringan : Skala 1-3

() Nyeri Sedang : Skala 4-6

() Nyeri Berat : Skala 7-9

() Nyeri Sangat Berat : Skala 10

Lampiran SOP Relaksasi Autogenik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RELAKSI AUTOGENIK

Pengertian	Terapi relaksasi autogenik adalah relaksasi dari diri sendiri dengan menggunakan kata-kata atau kalimat pendek yang bisa membuat pikiran menjadi tenang.
Tujuan	1. Mengurangi nyeri. 2. Mengurangi kecemasan.
Prosedur	1. Alat dan Bahan: 1) Lembar kuesioner data responden. 2) Lembar kuesioner nyeri. 3) SOP terapi relaksasi autogenik 2. Kondisi Pasien: 1) Pastikan pasien dalam keadaan stabil. 2) Lakukan penilaian awal tingkat nyeri pasien menggunakan skala nyeri.
Pelaksanaan	1) Bina hubungan saling percaya. 2) Posisikan pasien dengan nyaman. 3) Jelaskan tujuan dari Tindakan yang akan dilakukan dan prosedurnya. 4) Pasien dipandu untuk menarik napas perlahan melalui hidung, lalu tahan 2 detik, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. 5) Pasien dipandu membayangkan rasa berat di tangan dan kaki. "Tangan kanan saya terasa berat... tangan kiri saya terasa berat... kaki kanan saya terasa berat... seluruh tubuh saya terasa berat dan rileks." 6) Pasien dipandu untuk membayangkan kehangatan di anggota tubu. "Tangan kanan saya terasa hangat... tangan kiri saya terasa hangat... kehangatan menyebar ke seluruh tubuh saya." 7) Pasien dipandu untuk menyadari detak jantungnya. "Jantung saya berdetak dengan tenang dan teratur." 8) Pasien dipandu merasakan napasnya tertur. "Pernapasan saya tenang dan teratur... udara masuk dan keluar dengan lembut." 9) Pasien diajak merasakan kehangatan diperut. "Perut saya terasa hangat dan nyaman." 10) Pasien dipandu untuk membayangkan kesejukan pada dahi untuk menenangkan pikiran. "Dahi saya terasa sejuk dan tenang... pikiran saya jernih dan damai."
Evaluasi	1. Pasien tampak rileks. 2. Rasa nyeri berkurang.

Lembar Lembar Observasi

LEMBAR OBSERVASI

[illegible]



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG

Terakreditasi B (Baik Sekali) **BAN - PT**

Program Studi :

1. Diploma III Kebidanan
2. Sarjana Keperawatan
3. Profesi Ners
4. Sarjana Gizi
5. Sarjana Kebidanan
6. Pendidikan Profesi Bidan

Alamat : Jl. Veteran Mancar Peterongan Jombang Telp./Fax. 0321 - 877025

Jombang, 27 November 2025

Nomor : 371/SHJ/S.Pend/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Studi Pendahuluan
Penelitian

Kepada,-
Yth. Direktur RS Prima Husada Sukorejo
Di -
TEMPAT

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir berupa Skripsi bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Husada Jombang Tahun Akademik 2025/ 2026, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : **FARID WAHYUDI ANTOK**
NIM : 2024 03 0262
Prodi : Sarjana Keperawatan STIKes Husada Jombang
Tempat Penelitian : Di RS Prima Husada Sukorejo

Bersama ini kami mohon agar mahasiswa termaksud mendapatkan ijin dan kesempatan melakukan studi pendahuluan serta diberikan data - data yang berkaitan dengan Penelitian dengan judul "**PENGARUH PEMBERIAN TERAPI RELAKSASI AUTOGENIK TERHADAP TINGKAT NYERI PRE OPERASI PADA PASIEN PRO EXCISI TUMOR MAMAE DI RUANG IKO RS PRIMA HUSADA SUKOREJO**".

Demikian atas bantuan dan kebijakaannya di sampaikan ucapan terima kasih.

Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Husada Jombang


Bagus Sulianto, ST.,MM.

NPP. 010706031